ONEMA-POP-043 — Versão institucional 1.0

Status: Aprovado pelo RT · Vigência: 09/11/2026 · Responsável técnico: Enf. Marcos Roberto Alves, COREN-SP 983558

ONEMA-POP-043 — Classificação de Risco Digital ONEMA —
Protocolo Institucional em Desenvolvimento

1. Identificação institucional

técnica

2. Objetivo e abrangência

Padronizar a atuação de enfermagem em: Classificação de Risco Digital ONEMA — Protocolo Institucional em Desenvolvimento. Aplicável a visitas e/ou triagem digital conforme pertinência, sem substituir serviço de emergência.

3. Competência, indicações e contraindicações

Enfermeiro habilitado, treinado e autorizado; Classificação preliminar de risco no canal digital; algoritmo é suporte, nunca diagnóstico, prescrição ou substituto de julgamento do enfermeiro. Não realizar intervenções além da competência, prescrição ou recursos disponíveis.

4. Materiais e equipamentos; fornecimento

Enfermeiro: roteiro de triagem, acesso à Carteira Digital e contatos de emergência; paciente: localização atual, telefone e pessoa de apoio. Equipamentos de avaliação clínica de uso profissional são providos pelo enfermeiro; consumíveis do paciente conforme contratação.

5. Avaliação clínica e preparação

Queixa principal, início, intensidade, sinais de perigo, comorbidades, medicações, estado mental e capacidade de responder. Confirmar identificação, consentimento, privacidade e localização para eventual emergência.

6. Execução técnica individualizada

1. Confirmar identidade, localização e número para retorno antes de iniciar a triagem.

2. Investigar imediatamente ameaça à vida: inconsciência, dispneia grave, dor torácica, AVC, convulsão,

sangramento importante.

3. Se ameaça à vida, classificar emergência e orientar SAMU 192 sem aguardar pontuação automatizada.

4. Se sem emergência evidente, aprofundar história dirigida e avaliar sinais vitais disponíveis, identificando

limitações de confiabilidade.

5. Definir prioridade provisória com justificativa clínica explícita; não usar escore isolado para descartar risco.

6. Se informação insuficiente ou contato instável, elevar nível de cautela e indicar avaliação presencial.

7. Registrar classificação, horário, sinais positivos/negativos, profissional responsável e orientação de destino.

8. Confirmar entendimento do paciente e encaminhamento; reclassificar se surgirem novos sintomas.

7. Interrupção, intercorrências e encaminhamento

Qualquer sinal de deterioração, inconsistência de dados ou impossibilidade de avaliação segura: interromper triagem rotineira e escalar.

8. Cuidados posteriores e orientações

Informar que classificação não é diagnóstico nem garantia de ausência de risco.

9. Registros obrigatórios na Carteira Digital ONEMA

Registrar identificação, data/hora, modalidade, consentimento, queixa, avaliação, achados positivos/negativos, etapas realizadas, intervenções não realizadas e justificativa, comunicação com RT/rede, encaminhamento, orientações, plano de retorno e assinatura do enfermeiro.

10. Referências específicas e rastreáveis

 COFEN — Resolução 736/2024, Processo de Enfermagem — https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-736-de-17-de-janeiro-de-2024/

 OMS — Patient Safety: Global Patient Safety Action Plan 2021–2030 — https://www.who.int/publications/i/item/9789240032705

Referências consultadas como suporte temático; a correspondência exaustiva entre cada passo e a evidência, bem como regras locais e manuais dos fabricantes, requer análise pelo RT.